



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : امنه علي نصرالدين +++
 المحافظة : الجيزة
 الحي / المدينة : كرداسه
 رقم البطاقة : 25803112101462 رقم التليفون : 01012171821
 العمر (تاريخ الميلاد) : 11-03-1958 المهنة : ربه منزل
 العنوان : ++++
 تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
 الإخصائي الاجتماعي
 التوقيع: (-----)
 المقر بما فيه
 التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
 الاسم: د/ندى حسن
 الاسم: د/نرمين رمضان
 الوظيفة: -----
 الوظيفة: -----
 الوظيفة: -----
 التوقيع: -----
 التوقيع: -----
 التوقيع: -----
 أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
 تعتمد صحة البيانات المرفقة
 رئيس اللجنة ومدير
 المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
 خطة العلاج : -----
 المستشفى : -----
 قسم : -----
 نفقات : -----
 جهة العلاج : -----
 ملاحظات : -----

ختم
 شعار الجمهورية

مدير عام
 مديرية الشؤون الصحية

رئيس
 المجلس الطبي المتخصص

--

Name: امنه علي نصرالدين +++ National ID: 25803112101462	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



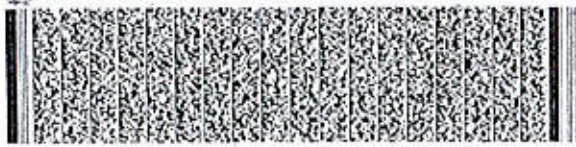
المنه
على نصر الدين
١٠ منشأة الكباري
مركز كرايمه - الجيزة

١٩٥٨/٠٣/٢١ ٢٥٨٠٣١١٢١٠١٤٦٢
I01918391

٢٠٢٠/٠٩ ٢٥٨٠٣١١٢١٠١٤٦٢

ربه منزل
أنثى
مسلمة
ارملة

١
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٩/١٢







Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name: أمينة علي محمد الدين

Sex:

3- Medical numbers:
Female

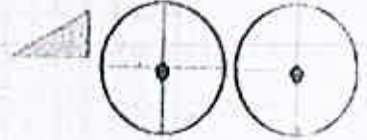
83118115

Old Med:

1936/2022

2-ID numbers: 25803112101462

Patient Age: 65 Y



Family History

Phone

01012171821

BMI

REASON OF MDT POST NACT

marital status WIDOW

NRS Score

01000000000

GROUP

Date of MDT 03/09/2023

Co morbidity HTN

Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
FREE LN (0/6)

BX:

ER:

PR:

Her 2 Neu :

SISH :

KI67 :

IDC

6/8

3/8

+VE

15

G2

T

2

N

1

M

Sonomammography

PATIENT HISTORY

PT FINISHED 6 TCHP NACT----LT BCS ---- YPTO YONO
STARTED AI FEMARA + CONTINUE HP TILL MDT
LT BCS :PCR

MDT OUTCOME & PLAN

FOR CONTINUE HERCEPTIN 600MG S.C FOR 1YEAR
PORT
ARAMEDIX FOR 7YRS
PROLIA/6MS

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

Dr. Mohamed El-Dokki

RADIOLOGY

9/13/23
Dr. El-Dokki

SURGERY

PATHOLOGY

Psychiatric

Nutrition



Patient Name: Amna Ali Nasr Al Din	Date : 07/01/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 1936/2022	Pat. ID: 11840

**Combined bilateral breast mammography and complementary
ultrasound**

Indication:

Left breast palpable lump.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Regressive course regarding left breast UIQ irregular spiculated high density masses.
- Complementary ultrasound showed left breast UIQ irregular spiculated hypoechoic masses, with internal vascularity on color Doppler application, seen at 9 o'clock, measured 1 x 1.5 cm compared to 1.5 x 1.7 cm, smaller adjacent lesion is also noted measures 0.5 cm, consistent to the palpable lump.
- No right breast suspicious cystic or solid mass lesions.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Nonspecific right axillary LN.
- Regressive course regarding pathological left axillary lymph nodes.

Opinion:

- Follow up post NACTH showing partial therapeutic response (BIRADS 6).
- Right breast normal study (BIRADS 1)

Signature Dr. Aya Deabes

07/01/2023 1:37 PM

Patient Name	الأمثلة / أمينة علي نصر الدين	Request No.	13002054
Patient No.	26803112101462	Request Date	09/05/2022
Path No.	1193/22	Verification Date	21/05/2022
Sex	Female	Financial Category	أورام دار السلام - مهور
Age	60 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		IHC No.	
		Registered by	Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast 11 o'clock malignant looking mass.

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy, collected at 9/5/2022, at 11:40 AM.

Gross Examination:

Multiple grayish white and fatty tissue cores, up to 2.5 cm, totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): II (3+3+2)
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 5/8)
- PR: Moderate nuclear reaction in 10% of tumor cells (Allred score 3/8)
- Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)
- Ki 67: 15 % nuclear reaction

Diagnosis:

Left breast mass; Tru cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, grade II
- ER : Positive (8/8)
- PR : Positive (3/8)
- HER2 : Positive (score 3+)
- Ki67: 15%

Prof. Dr. Aml Hareedy

Verified by:

Dr. Marwa mahmoud

Printing Date: 25/05/2022 09:41:58

Page 1 of 2

Printed By: marwa mohamed youss



Pathology Report

Clinical Data:

Left breast cancer , post NACT

Nature of the specimen:

Left WLE & SLNB specimens , collected at 12/2/23

Gross Examination:

Two specimens were received .

SLNB - Fibrofatally tissue piece measured 5x3 cm , enclosing 6 nodules up to 1.5x1cm

Left WLE specimen measured 8x6x1.5 cm with covering skin ellipse measured 8x1.5 cm.

• Tumor extent

• Number: An ill defined rubbery to firm greyish white tumor bed site

• Size: 1.7x1.5 cm

• Distance from margins: 0.8 cm from superior margin (least margin)

• Frozen section:

• Free SLNs (0/5) and one suspicious lymph node

• Free resected margins

Microscopic examination:

• Total tumor regression in a previously diagnosed invasive carcinoma

• Angiolymphatic invasion: Not detected

• Ductal carcinoma in situ: Not detected

• Lymph node involvement: Free lymph nodes (0/6)

• Resection Margins: Free all resected margins

• Histologic response to therapy: Pathologic complete response

• Additional pathologic findings: Focal microcalcifications

Diagnosis:

Verified by :

walaa ghoniem

Printing Date : 26/02/2023 10:44:40

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



Patient Name : **عبد الحفيظ بن عبد الوهاب**
Patient No. : 25803112101462
Path No. : 435/2023
Sex : Female
Age : 60 Y
Referring Doc :
Request No. : 13001714
Request Date : 12/02/2023
Verification Date : 21/02/2023
Financial Category : **مريض - Out Patient**
Department : **Out Patient**
Registered by : **All mostafa**

Pathology Report

Left breast cancer post NACT , WLE & SLNB specimens :
-Pathologic complete response in a previously diagnosed carcinoma
-Free all resected margins
-Free lymph nodes (0/6)
-Stage : ypT0 , ypN0

Prof Gamal Abdellaty
Dr Esraa Magdy

Verified by :
wataa ghomem

Printing Date : 26/02/2023 10:44:40

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name: Amna Ali Nasr Al Din	Date : 10/06/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 66 Year(s)
Medical ID: 1936/2022	Pat. ID: 11840

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH
RESOLUTION ULTRASOUND**

Indication:

breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Bilateral benign looking vascular calcifications.

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable masses
- Diffuse left breast skin thickening.
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Right Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Signature Dr. Mohamed Mohsen

10/06/2024 4:52 PM

ADULTISLICE NON CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST:

FINDINGS:

- Left breast overlying skin thickening.
- Left upper lobar subpleural reticulations and honeycombing likely post therapeutic sequel.
- No pathologically enlarged axillary lymph nodes.
- Few bilateral tiny pulmonary nodules the largest is seen at lateral segment of middle lung lobe measuring 2 mm.
- Prominent relatively hyperdense mediastinal lymph nodes in short axis.
- No plural or pericardial collection.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Moderate cardiomegaly.
- No pericardial effusion detected.
- Left thyroid gland hypodense nodule.

❖ Status follow up showing the above described changes.

Dr. Nourhan M/



NUCLEAR MEDICINE UNIT

Patient Name: Amna Ali NasrEldin

Date: 18/7/2022

وحدة الطب النووي

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted in the dorso-lumbar vertebrae.
- Both kidneys are seen

Conclusion:

- *The surveyed skeleton is free of any osseous deposits.*

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit

DR/Sherien Mahdy, MD